

Guia de Acolhimento do Interno

Serviço de Medicina Intensiva da ULSLO

Diretor de Serviço

Dr. Pais Martins

Autor:

Dr. Gonçalo Guerreiro

Revisão:

Dra. Cláudia Martins

Dra. Marta Rebelo

1ª Edição 2024



ÍNDICE

Página

1. O Serviço de Medicina Intensiva	3
2. Mensagem de Boas-vindas aos jovens Internos	5
3. Organização do Serviço de Medicina Intensiva	6
4. Circuito do Doente Crítico	12
5. Equipa de Emergência Intra-hospitalar	13
6. Requisitos para a realização do Estágio no SMI	15
7. O Estágio de Medicina Intensiva	17
7.1 Duração e Avaliação	17
7.2 Elementos de referência	18
7.3 O dia a dia na Unidade de Cuidados Intensivos	19
7.4 Registos clínicos	22
7.5 Outros momentos de Formação	28
7.6 Objetivos	29

1. O SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA DA ULSLO

MISSÃO

O Serviço de Medicina Intensiva (SMI) da Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental (ULSLO) tem como missão a identificação precoce e o tratamento eficaz dos doentes com falência de órgão, estabelecida ou iminente.

É missão do SMI a organização e coordenação dos recursos existentes na ULSLO com áreas dirigidas à assistência clínica, à investigação e à formação pré e pós-graduada que visam contribuir para uma maior eficiência técnica e social, promover uma maior qualificação, rentabilização das estruturas e melhor prestação de cuidados de saúde.

VISÃO

O SMI apresenta-se como uma referência nacional no tratamento do doente crítico, possuindo um corpo de profissionais altamente qualificados, que cuidam dos doentes e suas famílias, com elevados padrões de qualidade e humanização, e cujo desempenho contribui para a confiança da população no SNS.

ÁREA DE INFLUÊNCIA

Para além da área de influência da ULSLO, o SMI enquanto polo do Eixo de Referência CHLO da Rede Nacional de Especialidade Hospitalar e de Referência de Medicina Intensiva, presta assistência a uma população que ultrapassa o milhão de pessoas. Este eixo engloba o H. de Cascais, o H. Garcia da Orta (ULS de Almada-Seixal), o Centro Hospitalar de Setúbal (ULS da Arrábida) e o Centro Hospitalar Barreiro-Montijo (ULS do Arco Ribeirinho).



ÁREA ASSISTENCIAL CLÍNICA

O SMI é uma estrutura orgânica da ULSLO, incluída na Área do Doente Crítico e que integra as seguintes áreas funcionais:

- UCI 1, 2, 3 e 4
- Circuito do Doente Crítico (CDC):
 - ✓ HSFx em cooperação com o Serviço de Urgência
 - ✓ HEM – Circuito do Doente Neurocrítico (UML)
- Emergência Médica Intra-Hospitalar (EEMI)
- Consulta de *Follow-up*
- *Outreach*
- Apoio à UCI da CCT do HSC

2. MENSAGEM DE BOAS-VINDAS AOS JOVENS INTERNOS

Bem-vindo(a) ao Serviço de Medicina Intensiva!

Como sabes, a Medicina Intensiva é uma especialidade médica que aborda a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de situações de doença aguda potencialmente reversíveis em doentes críticos que apresentam falência de uma ou mais funções vitais, iminente(s) ou estabelecida(s).

A formação em Medicina Intensiva dar-te-á as ferramentas necessárias para poderes abordar o doente crítico com segurança e assertividade. Se estás a iniciar a tua formação na especialidade de Medicina Intensiva, este será o início da tua formação para a vida!

Antes de iniciar esta jornada, aqui vão algumas informações úteis sobre o nosso Serviço de Medicina Intensiva.



3. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA

Tal como já descrito, o SMI é uma estrutura orgânica da ULSLO incluída na Área do Doente Crítico, dirigida pela Dra. Cláudia Martins, de que fazem parte o Serviço de Anestesiologia, o Serviço de Urgência e a VMER.

O Diretor do SMI é o Dr. Pais Martins.

Para além de toda a atividade assistencial, o SMI é responsável pela formação:

- **pré-graduada:** alunos de Medicina da NOVA Medical School/Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa.
- **pós-graduada:** formação de internos de formação especializada de vários Serviços do Hospital e de outros Hospitais.

O SMI realiza investigação na área do doente crítico, assim como participa em diversos ensaios multicêntricos nacionais e internacionais, integrando diversas redes de colaboração.

A sua diferenciação técnica e clínica fazem do SMI um Serviço procurado por internos que pretendem uma formação consistente, integrada e multidisciplinar.

Aqui vai um pouco de informação sobre as diversas unidades que constituem o Serviço onde irá decorrer a tua formação.

3.1 UCI-1

A UCI-1 está localizada no 5º piso do Hospital Egas Moniz (HEM), sendo a mais antiga unidade de Lisboa (e 2ª nacional). Coordenada pela Dra. Isabel Simões, esta unidade tem 11 camas, 8 em *open-space* e 3 de isolamento.

A UCI-1 recebe doentes pós-cirúrgicos diretamente dos blocos operatórios do HEM e doentes médicos oriundos das enfermarias do HEM.

A Unidade é responsável pela Emergência Intra-Hospitalar no HEM e, em conjunto com o Serviço de Medicina Interna, pela Unidade de Cuidados Intermédios Médicos, localizada no 3º piso.

3.2 UCI-2

A UCI-2 localiza-se no piso 3 do edifício do Internamento do Hospital Egas Moniz, em proximidade com o bloco operatório e as enfermarias de Neurotraumatologia, de Neurocirurgia e de Neurologia.

Coordenada pelo Dr. Pedro Freire a UCI-2 é uma unidade vocacionada para o tratamento do doente neurocrítico, tem 8 camas, duas das quais de isolamento.

A UCI-2 tem ainda a seu cargo 3 camas da Unidade de Cuidados Intermédios no Serviço de Neurocirurgia.

3.3 UCI-3

A UCI-3 está localizada no piso –1 do Edifício 1 do HSFX. Coordenada pela Dra. Joana Osório, tem 9 camas, duas delas de isolamento.

Esta unidade encontra-se especialmente vocacionada para o tratamento do doente cirúrgico e politraumatizado, recebendo também doentes médicos e cirúrgicos, quer do SU, quer das enfermarias, blocos operatórios e bloco de partos.

3.4 UCI-4

A UCI-4 está localizada no 1º piso do Edifício 1 do HSFX. Coordenado pelo Professor Doutor Pedro Póvoa, tem 8 camas, divididas por dois quartos.

É uma unidade polivalente, recebendo maioritariamente doentes médicos oriundos do SU, das enfermarias do HSFX. Recebe também doentes cirúrgicos e politraumatizados.

A UCI-3 e UCI-4 são corresponsáveis pela Emergência Intra-Hospitalar do HSFX e pelo Circuito do Doente Crítico (CDC).

3.5. CIRCUITO DO DOENTE CRÍTICO (CDC)

O Serviço de Urgência (SU) do HSFX é um Serviço Polivalente, tendo assim capacidade para o tratamento de doentes com patologia médica e cirúrgica urgente e emergente, incluído politraumatizados e doentes neurocríticos.

Na Sala de Reanimação (REA) são admitidos os doentes críticos vindos diretamente do exterior ou das restantes alas do SU.

O SMI é o responsável pelo Circuito do Doente Crítico (CDC) que dá resposta à necessidade de reconhecimento e abordagem precoce de doentes críticos admitidos no SU, respeitando as orientações clínicas e formativas do colégio de especialidade de Medicina Intensiva e a Rede de Referência de Medicina Intensiva. Essa estratégia assenta numa parceria entre o Serviço de Medicina Intensiva da ULSLO e o SU do HSFX/ULSLO. A atividade do CDC é assegurada por um médico sob coordenação do SMI, em presença física hospitalar

O CDC é parte integrante da tua formação, terás assim oportunidade de acompanhar (fase inicial) e de ser escalado (fase avançada) este Circuito.

É um momento de aprendizagem fundamental do teu percurso formativo

3.6. EQUIPA DE EMERGÊNCIA INTRA-HOSPITALAR (EEMI)

A EEMI é composta por um médico e enfermeiro do SMI, possuindo equipamento e escala própria. Tal como o CDC, poderás acompanhar quem está destacado na escala. A EEMI pode ser ativada por qualquer profissional de saúde do hospital, a partir dum telefonema para o nº 2222, apresentando critérios de ativação definidos:

- Compromisso da via aérea;
- Paragem respiratória / FR <6 ou >35 cpm / SpO2 < 85% com O2 suplementar;
- Paragem Cardíaca / FC <40 ou >140 bpm + Sinais de gravidade / PAS <80 ou PAM <60mmHg;
- GCS <10 ou diminuição aguda >2 pontos/crise convulsiva;
- Preocupação da equipa assistencial e ou ausência de resposta ao tratamento prévio.

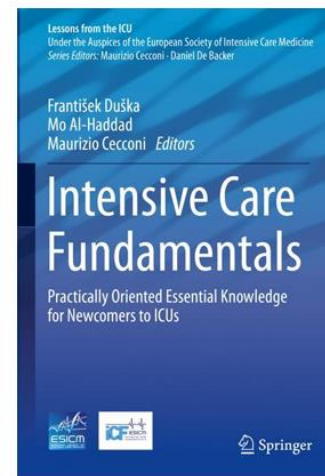
A sua área de intervenção engloba todo o HSFx e HEM (áreas clínicas e não clínicas) com exceção do SUG, Serviço de Urgência Pediátrica, Serviço de Pediatria, Serviço de Neonatologia, Blocos Operatórios e Unidades de Cuidados Intermédios.



6. COMPETENCIAS COMPLEMENTARES

O Plano de Formação em Medicina Intensiva recomenda a frequência de diferentes formações pós graduadas nomeadamente as organizadas pela SPCI, ESICM, Reanima, em particular na área de infeção e Sépsis, ventilação, ecografia, SAV, ATLS ou ETC, entre outros.

A Sociedade Europeia de Cuidados Intensivos (ESICM) preparou um livro de especial interesse para novatos nesta área: ***Intensive Care Fundamentals: Practically Oriented Essential Knowledge for Newcomers to ICUs***. É um livro com cerca de 250 páginas de fácil leitura e compreensão que te poderá ajudar bastante na fase inicial da formação. Caso necessites de outras fontes bibliográficas, o teus colegas mais velhos terão todo o gosto em te ajudar.



7. INTERNATO DE MEDICINA INTENSIVA

7.1 DURAÇÃO E AVALIAÇÃO

A duração e avaliação do Internato de Medicina Intensiva é realizada de acordo com o disposto na legislação, Portaria n.º 103/2016 de 22 de Abril.

A duração do estágio de Medicina Intensiva dos restantes internos de outras especialidades, rege-se pelo seu plano curricular.

O modo de avaliação dependerá da duração do mesmo:

- < 3 meses – avaliação continua pelos elementos da Unidade onde o interno está colocado;
- ≥ 3 meses e < 6 meses: avaliação contínua com discussão de relatório e de caso clínico, feita por um elemento do *staff* residente e a Coordenadora da formação do SMI (Dr.ª. Cláudia Carvalho) ou alguém por ela designado;
- ≥ 6 meses: avaliação contínua com discussão de relatório e prova teórico-prática feita por um elemento da Unidade de colocação do interno e pela Coordenadora da Formação ;

Os Internos da Especialidade de Medicina Intensiva são avaliados continuamente e têm uma avaliação anual que consiste na elaboração e discussão de um relatório de atividades e prova teórico-prática. É realizada pelo Diretor do SMI, e por um Coordenador de uma das UCI.

7.2 ELEMENTOS DE REFERÊNCIA

Cada UCI possui um elemento de referência no que respeita à formação:

- UCI-1: Dra. Gabriela Almeida e Dra. Marta Rebelo
- UCI-2: Dra. Lia Lêdo
- UCI-3: Dra. Cláudia Carvalho
- UCI-4: Dr. Vítor Mendes

Conjuntamente com este coordenador, deverás passar **por 3 momentos de reflexão:**

1. à chegada, para definir objetivos;
2. a meio do estágio, um momento informal de auto e hetero avaliação;
3. final, para que possam em conjunto fazer uma análise do estágio identificando o que correu francamente bem e os aspetos em que possa haver melhoria.

7.3 O DIA-A-DIA NA UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS

Cada unidade tem o seu horário específico, pelo que te recomendamos que chegues um pouco antes das 8h30 à unidade no teu primeiro dia. O dia inicia-se com uma passagem clínica de doentes (que poderá ser na sala de médicos ou à cabeceira do doente). Esta é uma passagem mais curta do que a da tarde, onde o(s) médico(s) que permaneceram de urgência no dia prévio transmitem as intercorrências do turno e onde se define um plano de ação para o dia.

Segue-se depois o período de observação dos doentes, transporte a exames, procedimentos, registos clínicos, revisões terapêuticas e altas/transferências. Estes registos são feitos numa plataforma específica para UCIs, a PatientCare ICU®, da B-Simple. No primeiro dia do estágio, ser-te-á fornecido o acesso a esta plataforma. Toda os procedimentos e a terapêutica deverão ser revistos por um elemento sénior e posteriormente validados na passagem de doentes. Não tenhas medo em fazer perguntas pois estás cá para aprender.

A equipa de enfermagem é especialista no doente crítico. Uma boa história clínica passa não só pela colheita junto ao doente (quando comunicativo), mas também por uma avaliação objetiva e discussão com a equipa de enfermagem e/ou enfermeiro responsável pelo doente.

Não te esqueças também de te apresentar e respeitar a equipa (de enfermeiros, de assistentes operacionais, fisioterapeuta e assistente técnico) pois um estágio enriquecedor depende também das boas relações que conseguiste criar.

Tentamos que tudo fique pronto cedo, para permitir um fluxo de trabalho adequado e evitar tempos de inatividade clínica desnecessários. No final da manhã, deverás fazer o pedido de análises e, se necessário, radiografia de tórax dos doentes que viste para o dia seguinte. Os exames de imagens como TCs ou Ecografias formais deverão ser preferencialmente realizados durante a manhã, para não sobrecarregar a equipa da tarde/noite.

Após a pausa para o almoço (na cantina, ou se tiveres marmita, todas as unidades são equipadas com uma copa), realiza-se a passagem de doentes. Esta é uma passagem mais prolongada e detalhada onde se discutem as atitudes tomadas durante a manhã e plano individual para cada doente.



É importante que ao apresentares o(s) teu(s) doente(s) tenhas informações detalhadas mas concisas do internamento do doente, assim como os resultados analíticos e imagiológicos (pode ser usado o suporte informático caso seja necessário).

Se estiveres escalado de urgência, o teu percurso continua. Os doentes são todos revistos durante a tarde e à noite, sendo necessário a realização de novo registo clínico (mais resumido).

As admissões requerem uma colheita de história clínica detalhada quer previamente à admissão hospitalar, quer sobre o percurso já no hospital.

Muitas vezes será necessário a colocação de um acesso venoso central assim como uma cateterização arterial (ficarás proficiente na realização de ambas estas técnicas).



7.4 REGISTOS CLÍNICOS

Como atrás referido, o sistema de registos clínicos utilizado nas nossas UCIs é o **Patient Care UCI**. Poderás encontrar o link para este software através do atalho “*ULSLO apps*” no ambiente de trabalho. Deverás fazer *login* no sistema, após estares registado nesta plataforma (o utilizador e palavra-passe deverá ser o mesmo que os acessos aos computadores).

Após login, defines em que hospital e Unidade te encontras a estagiar. Ao seleccionares essa Unidade encontrarás um “ambiente de trabalho” com todas as camas da unidade dispostas segundo a sua real localização. Ao seleccionares um doente terás acesso aos seus diários, análises clínicas, gasometrias, prescrição, monitorizações, entre outros.

Para criar um diário, basta clicar no separador “diário” e de seguida no sinal de “mais”. A observação de doentes em UCI é realizada de forma pragmática, segundo órgãos e sistemas, efetuando no final a validação da **ICU-Checklist diária**. Esta é uma ferramenta de apoio que permite organizar uma série de tarefas e atividades que não devem ser esquecidas na nossa observação ao doente. Permite minimizar o erro médico e consequentemente promover melhoria na qualidade dos cuidados prestados.

Exemplos de itens dessa *checklist*:

- Cabeceira a 30º- Prevenção de Pneumonia Associada à Intubação (PAI)
- Analgesia eficaz- Prevenção e Controlo de *Delirium* em UCI
- Profilaxia para a Úlcera de Stress
- Profilaxia para o Tromboembolismo Pulmonar
- Dias de Antibioterapia e sua necessidade: Minimizar o risco de desenvolvimento de agentes multi-resistentes

Os mesmos itens são auditados todos os anos para avaliar a qualidade de serviços prestados pelo SMI.

Às 24h após admissão em UCI devem ser realizados os seguintes Índices de Gravidade, (que encontra no programa Patient Care ICU):

- **APACHE II**
- **SAPS III**
- **SOFA (diariamente)**

A primeira impressão é que se trata de um registo diário complexo, mas ao longo da primeira semana vais perceber a importância do mesmo na passagem de informação sobre o doente à restante equipa e de que forma te ajuda a prestares os melhores cuidados ao teu doente.

Somos uma especialidade integrativa. Os nossos doentes são admitidos em estado crítico e inúmeras vezes com situações complexas, que exigem uma abordagem multidisciplinar e apoio de outras especialidades, nomeadamente as cirúrgicas para controlo de focos infecciosos e/ou hemorrágicos, ou especialidades médicas para a realização de procedimentos que não são da competência de um intensivista, como: Endoscopia digestiva alta, Colonoscopia, Ecocardiograma transesofágico, entre outros.



A título de exemplo, apresentamos-te de seguida um diário típico da UCI

Analgesia e Dor	Analgesia basal com X Analgesia de resgate com X. Sem registo de dor (BPS máximo, 3) Confortável.
Sedação & Agitação Delírio & Sono:	Sob terapêutica sedativa hipnótica basal com X Sem Com terapêutica sedativa não hipnótica. Sem Com terapêutica neuroléptica Se aplicável, escala de RASS (sedação) Se aplicável, CAM-ICU (delírio).
Sistema Neurológico:	Nível de consciência X. Pupilas (na linha média, mióticas, isométricas). Reflexos fotomotores normais lentificados, Sem Sob bloqueio neuromuscular com X + BIS X (se curarizado). Sem lateralização motora e ou sensitiva aparente. Sob Sem terapêutica anticomicial (específica). Sem actividade epileptiforme clinicamente aparente.
Sistema Respiratório:	Sob suporte ventilatório mecânico invasivo em modo volumétrico pressão e assistido controlado – ex. VCV (PEEPt X cmH2O; pPlat X cmH2O [driving pressure X cmH2O]; Vt X mL Kg IBW; C’ X mL/cmH2O; R X cmH2O. s/L; stress index problemático). (Des) Adaptado Auscultação pulmonar X. Gasimetricamente com X - perfil em melhoria agravamento). Referência a secreções traqueais Reflexo de tosse presente / ausente e (in)eficaz Avaliação imagiológica torácica e ecografia torácica.

Sistema Cardiocirculatório e Renal Equilíbrio Hidroelectrolítico:	Suporte vasopressor com X em cinética ascendente descendente. Com Sem suporte inotrópico em curso. Com Sem terapêutica cronotrópica em curso. PAS, X mmHg; PAD, X mmHg; PAM, X mmHg. Perfil tensional tendencialmente hipotensivo hipertensivo. VPP, (?) %. FC, X bpm. Regular. AC: X. Transportador (Hgb.) não problemático (Hgb., >9.0 g dL). Sem necessidade de suporte transfusional (não registado suporte transfusional durante o período de internamento). Adequação Compromisso da perfusão tecidual sistémica (débito urinário residual, aprox. X mL Kg h, em doente sob TSRF terapêutica diurética; Indicadores funcionais renais em perfil de melhoria; Extremidades bem mal perfundidas com TPC adequado prolongado. Lactato, X mmol L. Sob TSFR contínua desde X, cumprindo HDFVVC [Qb (fluxo de sangue) a X mL min; Qd (dose de dialisante) a X mL h; Qr (dose de reposição) a X mL h, UF= X mL h]. Anticoagulação regional com Citrato ou Anticoagulação sistémica. Gasimetricamente, do ponto de vista metabólico, com X. Equilíbrio iónico sob suplementação de X. BH: X mL (balanço pré-admissão ao SMI, não contabilizado). BH24h, + ou - X mL.
Coagulação e Hemorragia:	Sem terapêutica antiagregante plaquetária. Sob HBPM em dose terapêutica, ajustada a disfunção renal – lesão renal aguda TSFR. Sem clínica hemorrágica. Hb X. Plaquetas X. Coagulação X.

Sistema Digestivo:	Profilaxia de úlcera de stress com IBP. Aporte calórico na dependência de: solução glicosada (D5PE; aporte calórico, X Kcal Kg dia; aporte proteico [EP], 0.0 g Kg dia) Alimentação entérica tipo X a X mL/h. Alimentação parentérica tipo X a X ml/h Perfil glicémico controlado, sem necessidade de correcção insulínica. Trânsito intestinal (não) funcionante (último registo de dejeção). Sob terapêutica laxante com X. Palpação e percussão abdominal. Sem avaliação da PIA. Enzimologia hepática sem alterações clinicamente relevantes. Sem drenos abdominais. Avaliação imagiológica abdominopélvica X.
Infecção:	Sob terapêutica ATB empírica dirigida com X, pela assumpção de infecção respiratória nosocomial (não associada a intubação [< 48h]). Com Sem registo de febre e sob corticoterapia sistémica em dose elevada terapêutica antipirética em esquema. Sem sinais inflamatórios aparentes nos locais de inserção dos diferentes dispositivos invasivos. Analicamente, com perfil inflamatório em cinética de agravamento melhoria. Sem achados microbiológicos potencialmente orientadores de descalção escalação da terapêutica ATB (aguarda os seguintes resultados de produtos colhidos X).

Conselho: Verifica sempre as perfusões que os doentes apresentam. Confirma se as diluições correspondem à prescrição e comunica as alterações junto com o enfermeiro responsável pelo teu doente. Não te esqueças que é um trabalho de equipa!

7.5 OUTROS MOMENTOS DE FORMAÇÃO

Existem ainda períodos formativos próprios com apresentação de casos, artigos ou reuniões de morbimortalidade.

Outras atividades formativas:

- Sessões Clínicas, com periodicidade variável, da responsabilidade de cada Unidade
- *Journal Club*, com temas apresentados pelos internos em formação específica a realizar estágio no SMI
- Sessões de formação internas das várias Unidades
- Cursos de formação organizados por alguns núcleos do SMI (ex: formação em Ecografia)

Como parte da formação dos internos de especialidade em Medicina Intensiva, o SMI proporciona ainda reuniões para internos, com periodicidade também variável, onde preletores especialistas em diversos temas nos vem dar formação.

Presença obrigatória!

Poderá também ser-te solicitado que apresentes um caso clínico ou artigo a integrar nas reuniões do tipo *Journal Club*. Estes são momentos de aprendizagem e treino, não te sintas pressionado!



7.6 OBJECTIVOS

Aquisição das seguintes competências básicas de Medicina Intensiva:

- Abordagem e estabilização do doente crítico;
- Conhecer as técnicas de permeabilização e abordagem da via aérea;
- Técnicas de monitorização de funções vitais e fisiológicas;
- Manuseio de sedação e analgesia;
- Conhecer fundamentos e cálculo de índices de gravidade;
- Conhecer os critérios de admissão e alta;
- Aprender noções de ética relacionadas com a especificidade do doente crítico;
- Adquirir competências na metodologia de suporte orgânico, com ênfase na instituição e manipulação de ventilação mecânica invasiva, ventilação não invasiva, prescrição e gestão de suporte vasopressor e inotrópico, técnicas de depuração renal;
- Aprender a abordar as infeções no contexto epidemiológico, diagnóstico, terapêutico e de prevenção;
- Identificar, monitorizar e tratar os diferentes tipos de choque;
- Abordagem de doentes em insuficiência respiratória;
- Adquirir conceitos de avaliação, prescrição e monitorização nutricional;
- Conhecer o circuito do doente crítico, participando nos processos de triagem e estabilização dos doentes da sala de emergência do Serviço de Urgência e dos doentes abordados pela equipa de emergência intra - hospitalar.

Durante período de formação deverás tornar-te proficiente nas seguintes técnicas:

- Colocação de CVC, cateter de diálise, linha arterial e respetiva interpretação
- Ecografia
- Ventilação mecânica

Bom internato!



CONTACTOS IMPORTANTES

- Diretor do Serviço de Medicina Intensiva
Telefone: 925648869
Email: ajpmartins@ulslo.min-saude.pt
- Diretora da Área do Doente Crítico (Dra. Cláudia Martins)
Telefone: 964566198/Ext 70455
Email: csmartins@ulslo.min-saude.pt
- Secretariado da Direção de Serviço (Carla Leitão)
Telefone: 210431233/Ext: 1233
Email: cleitao@ulslo.min-saude.pt
- Secretariado do Internato (Mariana Paulino)
Telefone: 210432319 Ext 2319
Email: internatomedico@ulslo.min-saude.pt